

SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO

Raquel Abad González, Jose Luis Prieto de la Rosa, Braulio Álvarez Martínez

INTRODUCCIÓN

Se trata de una lesión pulmonar inflamatoria difusa que cursa con daño del epitelio capilar y alveolar. El mecanismo fisiopatológico consiste en un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar que provoca edema alveolar secundario y pérdida del surfactante pulmonar, lo que lleva a la atelectasia de los alveolos y deterioro de la función respiratoria. Debido a su alta mortalidad, que se estima entre un 40-50%, es de vital importancia una sospecha y diagnóstico precoz.

DEFINICIÓN

Se deben de cumplir **3 criterios**:

1	Tiempo de inicio agudo , en la semana posterior a conocerse la alteración clínica o al empeoramiento o aparición de síntomas respiratorios.
2	Imagen torácica (Rx o TC) con opacidades bilaterales no justificable por la existencia de derrame, atelectasias o nódulos.
3	Origen pulmonar del edema no explicable por insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica. En caso de no haber causa probable desencadenante se precisaría una prueba objetiva (ecocardiograma) para excluir edema hidrostático.

El **grado de gravedad** vendrá definido por el grado de hipoxemia medido por la relación entre la PaO₂ y la Fi O₂ con un nivel mínimo de PEEP de 5cmH₂O (presión positiva al final de la espiración).